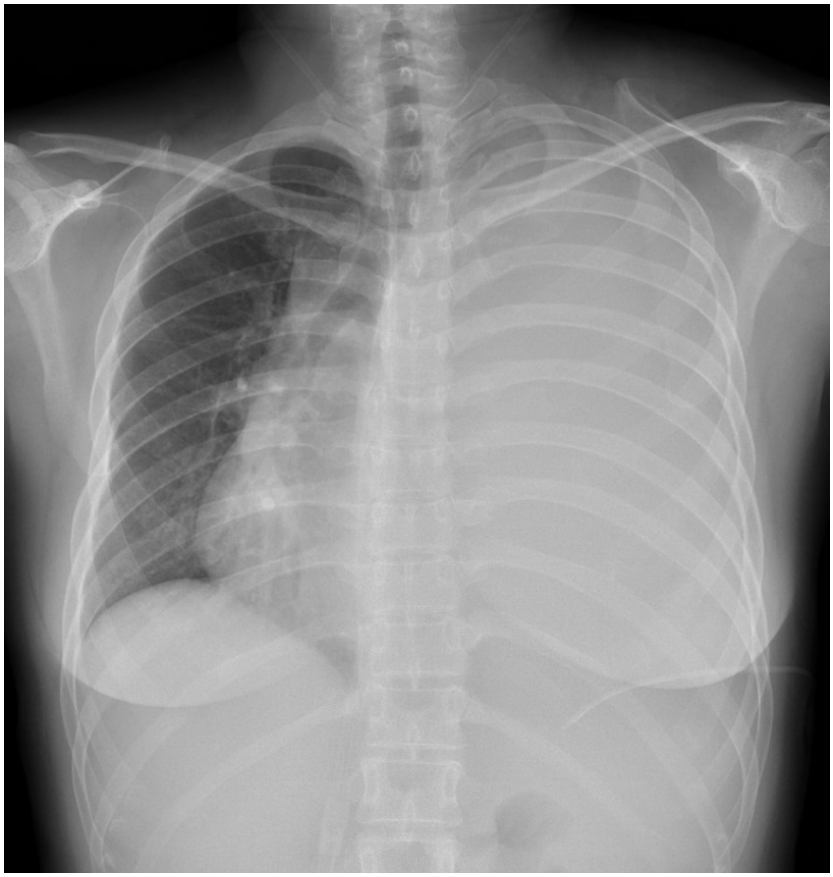
21. 흉부 X선 판독 TBL

진단의 기본 · 2025, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 11문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 박병건

2025년 시험 55번 · 출제자 박병헌

1. Chest radiograph에서 보이는 이상소견의 원인으로 가장 적절한 것은?



① Right pleural effusion

② Left pleural effusion

③ Total atelectasis of left lung

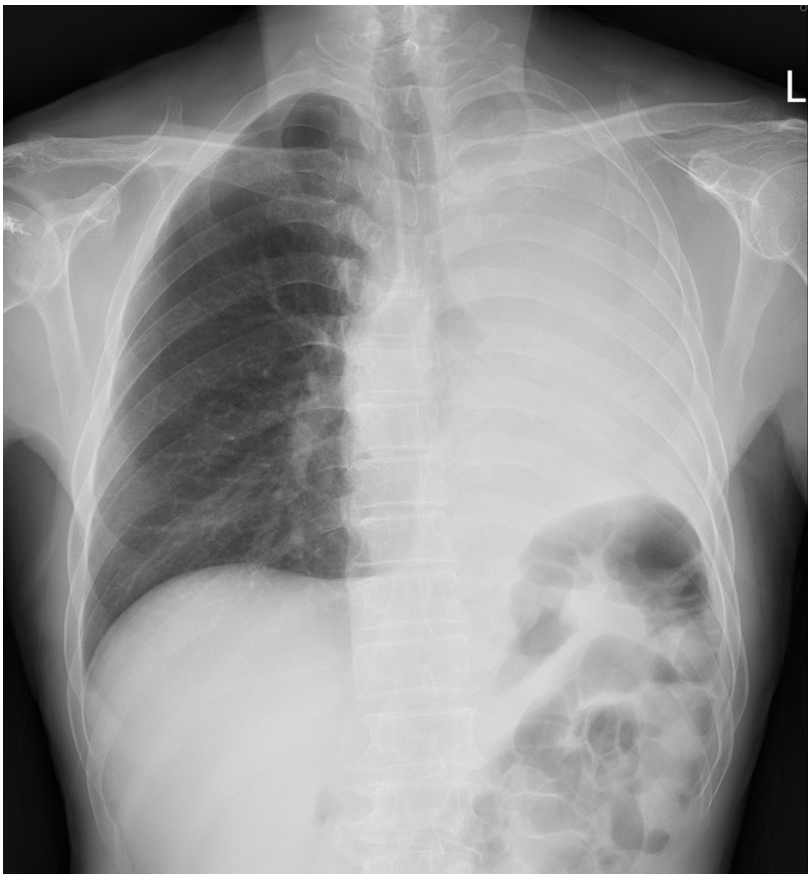
④ Total atelectasis of right lung

⑤ Status of left pneumonectomy

> **정답 ②**
>
> 왼쪽 흉곽 전체가 하얗게 보이고(white-out), 기관과 종격동 · 심장이 반대쪽(오른쪽)으로 밀려 있다. 한쪽 흉곽이 하얀데 종격동이 반대쪽으로 밀리면 부피를 차지하는 병변, 즉 다량의 흉막삼출(왼쪽)이다. 폐 전체 무기폐나 폐절제술 후 상태에서는 부피가 줄어 종격동이 같은 쪽(왼쪽)으로 끌려간다.

2023년 시험 10번

2. 기침과 호흡곤란을 주소로 시행한 69세 남자환자의 흉부 X-선 사진입니다. 맞는 설명을 모두 고르세요. (2가지)



① 기관 (trachea)의 위치와 모양은 정상이다.

② 환자의 왼쪽 폐용적(lung volume)이 감소되어 있으며 왼쪽 주기관지(main bronchus)를 막고 있는 병변이 의심된다.

③ 양쪽 횡경막(diaphragm)의 위치가 정상이며 폐실질과 횡경막의 경계가 잘 보인다.

④ 왼쪽 폐야 전체가 하얗게 보여서 다량의 흉막삼출(pleural effusion)이 있을 가능성이 크다.

⑤ 심장의 위치가 정상보다 왼쪽으로 치우쳐 있다.

> **정답 ②, ⑤**
>
> 왼쪽 폐야 전체가 하얗고, 기관과 심장이 왼쪽으로 끌려가 있으며, 왼쪽 횡격막이 올라가 있다(장 공기가 높이 보임). 부피가 줄어든 쪽으로 구조물이 끌려가므로 왼쪽 폐 전체의 무기폐이며, 원인으로 왼쪽 주기관지를 막는 병변(폐암 등)을 의심한다(②, ⑤). ① 기관은 왼쪽으로 치우쳐 있다. ③ 왼쪽 횡격막 경계는 보이지 않는다. ④ 다량의 흉막삼출이라면 종격동이 반대쪽으로 밀린다.

3. 64세 남자 환자가 dyspnea를 주소로 내원하였다. 가장 적절한 진단은?

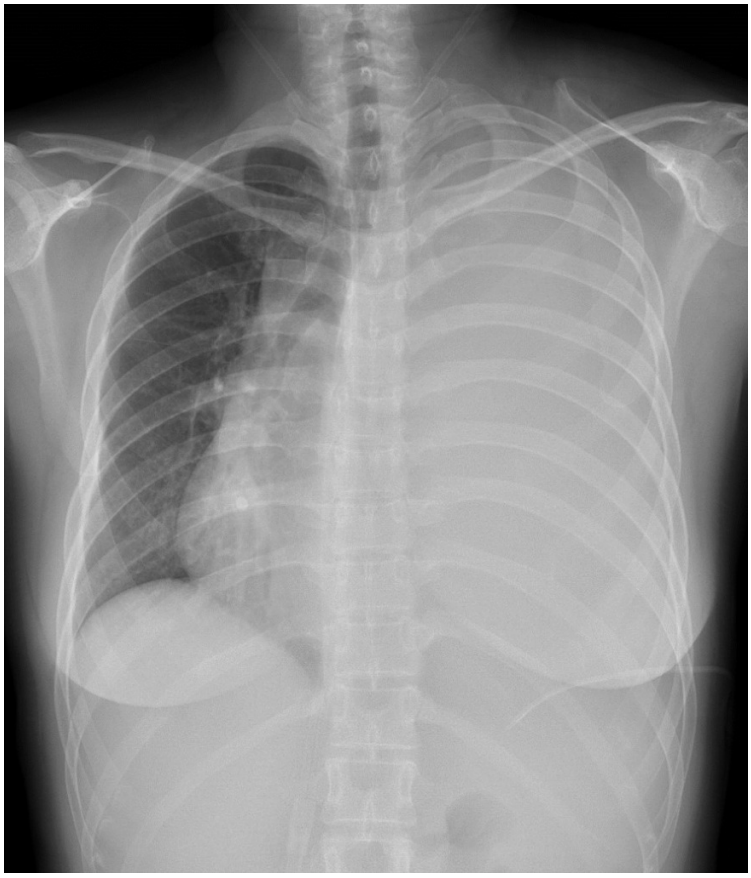


① Fungal ball
② Pneumothorax
③ Bacterial pneumonia
④ Pulmonary tuberculosis
⑤ Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF)

> **정답 ⑤**
> 양쪽 폐 아래쪽과 가장자리에 우세한 그물 모양(reticular) 음영과 폐용적 감소가 보이는 고령 남성의 호흡곤란은 특발성폐섬유증(IPF)의 전형적인 모습이다(CT에서는 흉막 아래 벌집모양이 특징). 진균구는 공동 안의 덩이, 기흉은 폐혈관이 없는 투명한 공간과 흉막선, 세균성 폐렴은 엽성 경화, 폐결핵은 상엽의 결절 · 공동이 특징이다.

2022년 시험 17번

4. 호흡곤란을 호소하는 69세 여자환자의 흉부 X-선 사진입니다. 맞는 설명을 모두 고르세요.(2가지)



① 기관(trachea)의 위치와 모양은 정상이다.

② 심장의 위치가 정상 위치보다 오른쪽으로 치우쳐 있다.

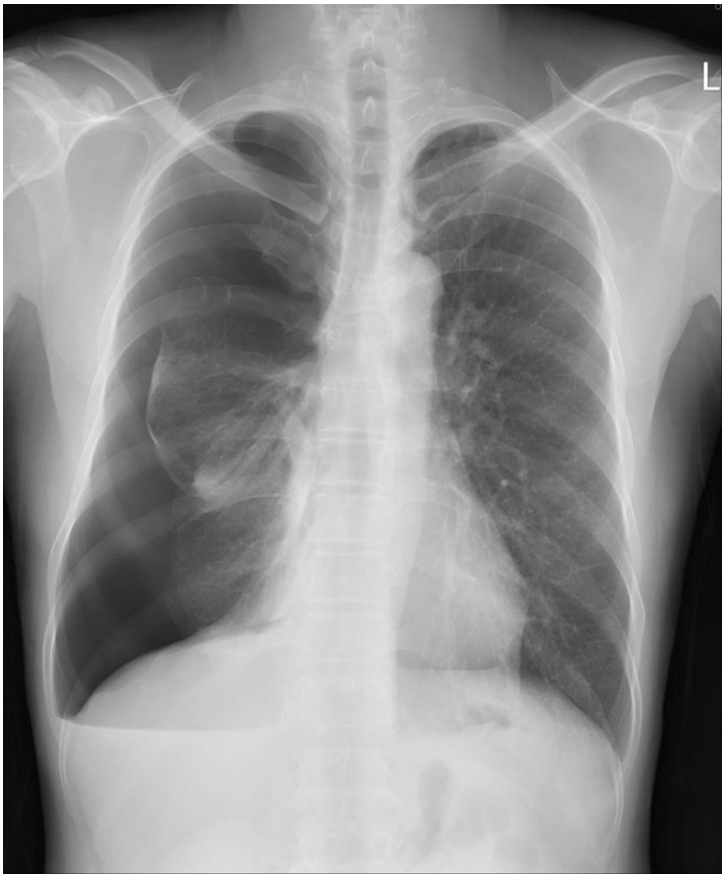
③ 양쪽 횡경막(diaphragm)이 폐실질과 구분되어 잘 보인다.

④ 왼쪽 폐야 전체가 하얗게 보이는 것은 폐용적의 감소에 의한 것으로 생각된다.

⑤ 왼쪽 폐는 다량의 흉수 (pleural effusion)가 의심되며 흉강(pleural cavity)에 drainage catheter (배액관)이 삽입되어 있다.

> **정답 ②, ⑤**
>
> 왼쪽 흉곽 전체가 하얗고 심장 · 종격동이 오른쪽으로 밀려 있으며, 왼쪽 흉강에 배액관(drainage catheter)이 들어가 있다. 종격동을 반대쪽으로 미는 white-out이므로 다량의 흉수다(②, ⑤). ① 기관도 오른쪽으로 밀려 있다. ③ 왼쪽 횡격막은 보이지 않는다. ④ 폐용적 감소(무기폐)라면 종격동이 왼쪽으로 끌려간다.

5. 흉통을 호소하는 환자의 단순 흉부 후전(Chest PA) 사진입니다. 맞지 않은 설명을 고르세요.



① 우폐의 변연부에는 정상적인 폐혈관 음영이 보이지 않는다.

② **좌폐의 음영이 비정상적으로 증가되어 있다.**

③ 기흉(pneumothorax)의 소견이다.

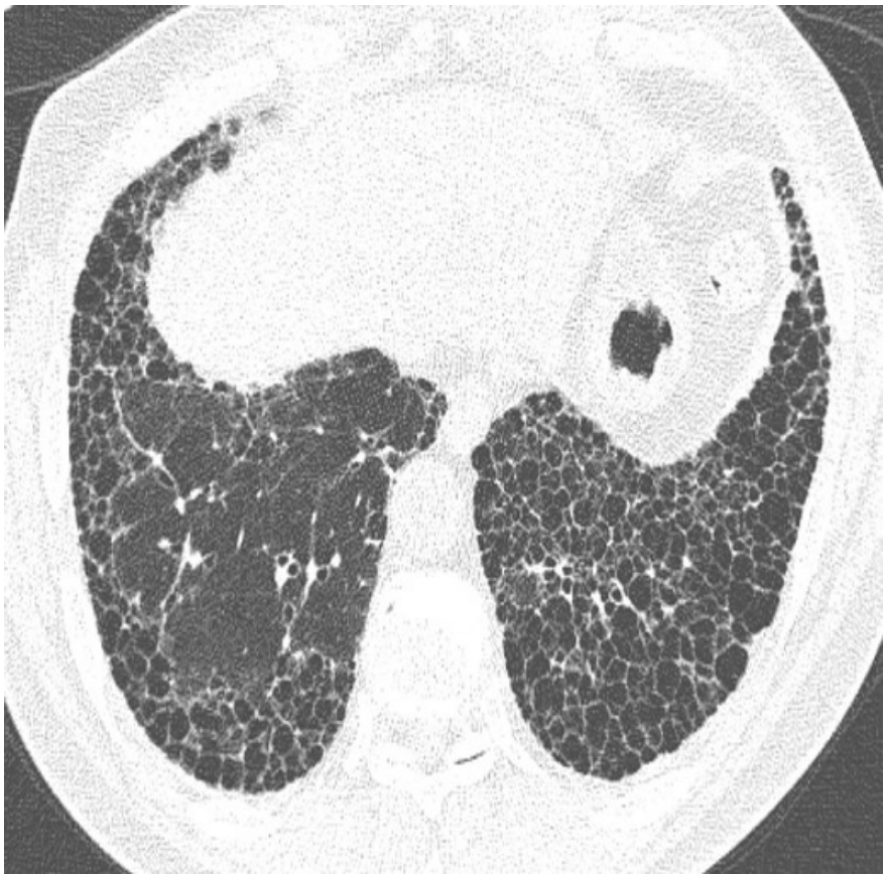
④ 우폐 변연부의 폐음영이 좌폐에 비해 감소되어 있다.

⑤ 우측 늑골횡경막각(costophrenic angle)의 blunting이 보이며 흉막삼출이 동반되어 있다.

> **정답 ②**
>
> 오른쪽 폐 가장자리에 폐혈관 음영이 없는 투명한 공간과 쪼그라든 폐의 경계선(흉막선)이 보여 오른쪽 기흉이다. 오른쪽 아래에는 수평한 공기-액체층이 있어 흉막삼출이 동반되어 있다(수기흉). 틀린 설명은 ②로, 왼쪽 폐는 정상이며 오른쪽 폐 가장자리가 오히려 더 검게(투명하게) 보인다.

2021년 시험 52번

6. 65세 남자 환자가 dypnea를 주소로 내원하였다. 아래의 CT image에서 보이는 주된 소견의 가장 적절한 표현은?



(원본 PDF에 보기 ①~⑤의 내용이 비어 있음)

①

②

③

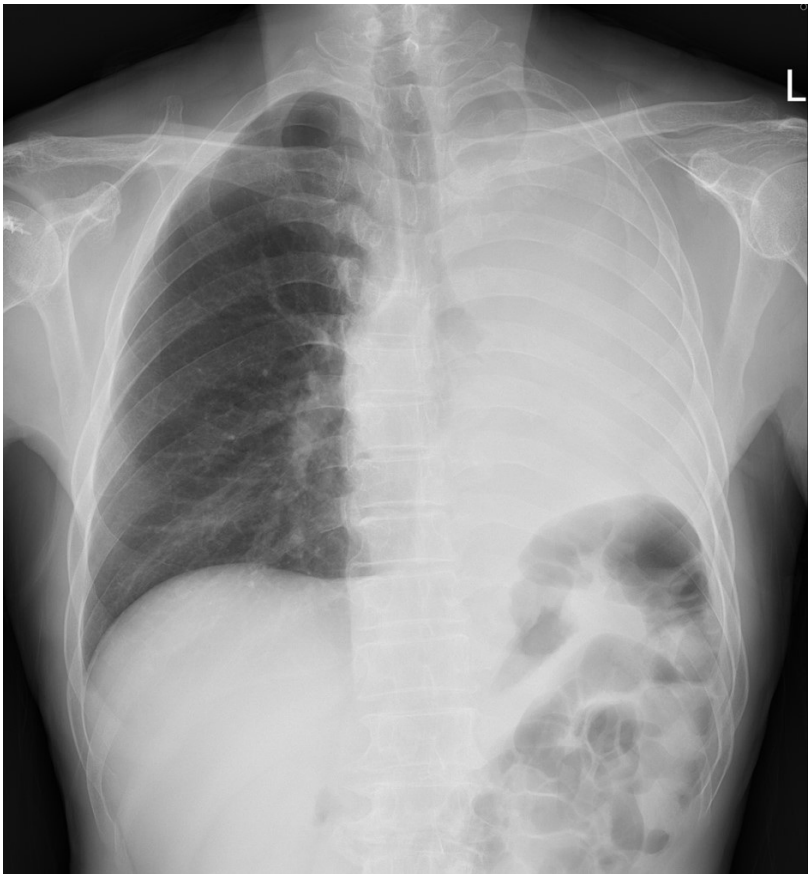
④

⑤

정답 ②

CT에서 양쪽 폐 아래쪽 흉막 바로 밑에 작은 낭종들이 여러 층으로 쌓인 벌집모양(honeycombing)이 주된 소견이다. 흉막하 · 하엽 우세 벌집모양은 통상간질폐렴(UIP) 패턴으로 특발성폐섬유증을 시사한다.
※ 원본에 보기 내용이 빠져 있다(정답은 ②로 표시됨). 보기의 원래 문구는 확인이 필요하다.

7. 기침과 호흡곤란을 주소로 시행한 69세 남자환자의 흉부 X-선 사진입니다. 맞는 설명을 하나만 고르세요.



① 왼쪽 폐야 전체가 하얗게 보여서 다량의 흉막삼출(pleural effusion)이 있을 가능성이 크다.

② 환자의 왼쪽 폐용적(lung volume)이 감소되어 있으며 왼쪽 주기관지(main bronchus)를 막고 있는 병변이 의심된다.

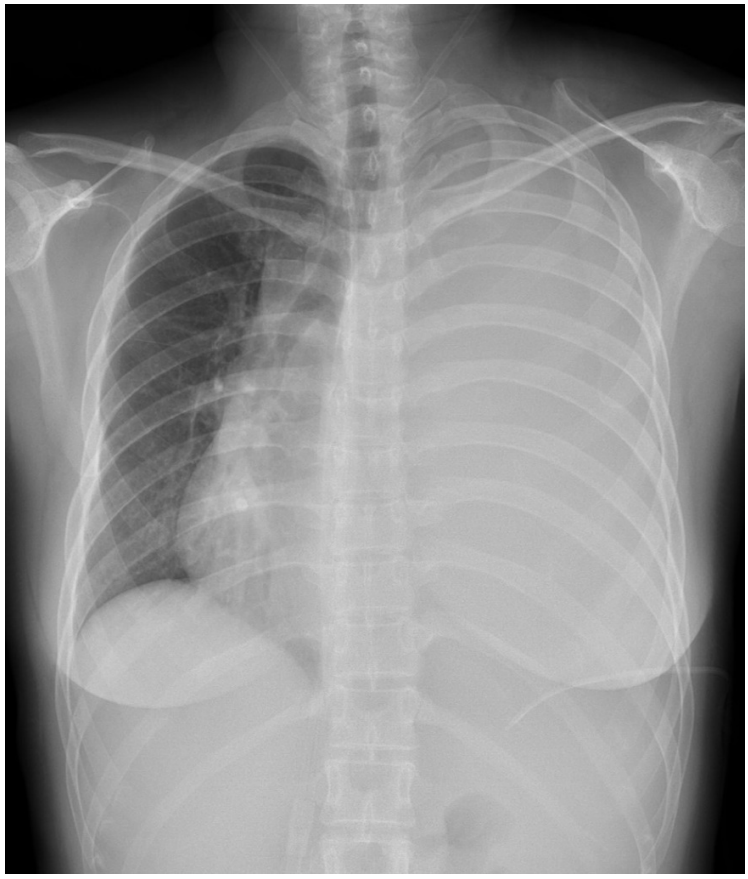
③ 양쪽 횡경막(diaphragm)의 위치가 정상이며 폐실질과 횡경막의 경계가 잘 보인다.

④ 기관(trachea)은 좌우로 치우치지 않고 정위치에 있다.

⑤ 심장의 양쪽 경계가 잘 보이며 C/T ratio는 정상범위이다.

> **정답 ②**
>
> 왼쪽 폐야 전체가 하얗고, 기관과 심장이 왼쪽으로 끌려가 있으며 왼쪽 횡격막이 올라가 있다. 부피가 줄어든 쪽으로 구조물이 끌려가므로 왼쪽 폐 전체의 무기폐이고, 왼쪽 주기관지를 막는 병변(폐암 등)을 의심한다. ① 다량의 흉수라면 종격동이 반대쪽으로 밀린다. ③ 왼쪽 횡격막 경계가 보이지 않는다. ④ 기관이 왼쪽으로 치우쳐 있다. ⑤ 왼쪽 심장 경계가 보이지 않는다.

8. 호흡곤란을 호소하는 환자의 단순 흉부 후전(Chest PA) 사진입니다. 맞는 설명을 모두 고르세요.(2가지)



① 환자의 몸이 오른쪽으로 회전된 상태에서 촬영되어 기관(trachea)의 위치가 정상 위치에서 벗어나 있다.

② 왼쪽 폐는 다량의 흉수(pleural effusion)가 의심되며 흉강(pleural cavity)에 drainage catheter(배액관)이 삽입되어 있다.

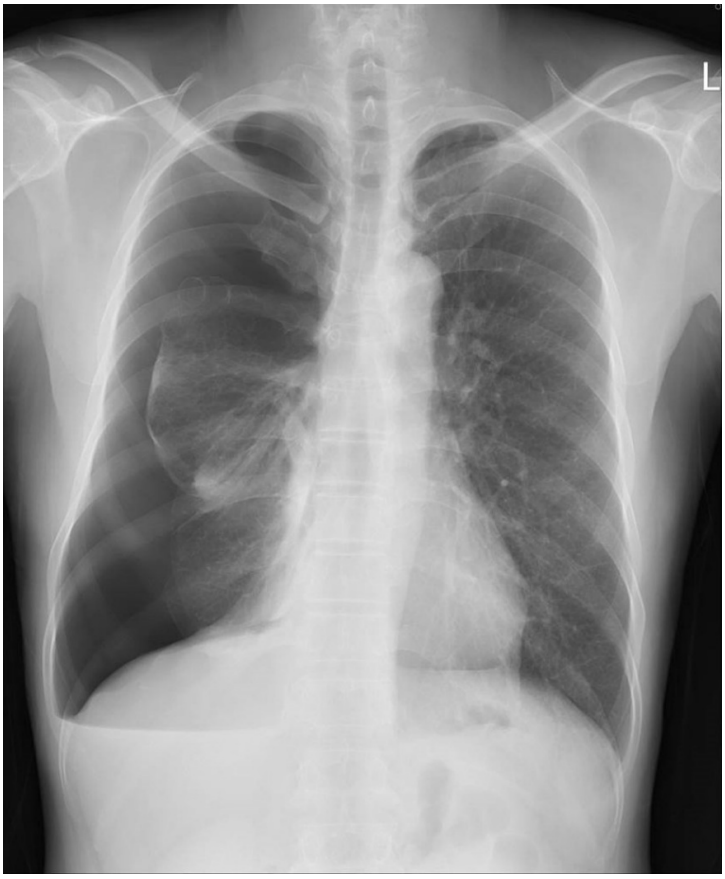
③ 심장의 양쪽 경계가 잘 보이며 C/T ratio도 정상이다.

④ 왼쪽 폐병변으로 인해 종격동(mediastinum)이 오른쪽으로 밀려있다.

⑤ 양쪽 횡경막(diaphragm)이 폐실질과 구분되어 잘 보인다.

> **정답 ②, ④**
>
> 왼쪽 흉곽 전체가 하얗고, 흉강에 배액관이 들어가 있으며, 종격동이 오른쪽으로 밀려 있다. 종격동을 반대쪽으로 미는 white-out이므로 다량의 흉수다(②, ④). ① 기관이 치우친 것은 회전 때문이 아니라 흉수가 밀어서다. ③ 왼쪽 심장 경계가 보이지 않는다. ⑤ 왼쪽 횡격막은 보이지 않는다.

9. 흉통을 호소하는 환자의 단순 흉부 후전(Chest PA) 사진입니다. 맞지 않은 설명을 고르세요.



① 우폐의 일부에는 정상적인 폐혈관 음영이 보이지 않는다.

② **좌폐의 음영이 비정상적으로 증가되어 있다.**

③ 기흉(pneumothorax)의 소견이다.

④ 우폐 변연부의 폐음영이 좌폐에 비해 감소되어 있다.

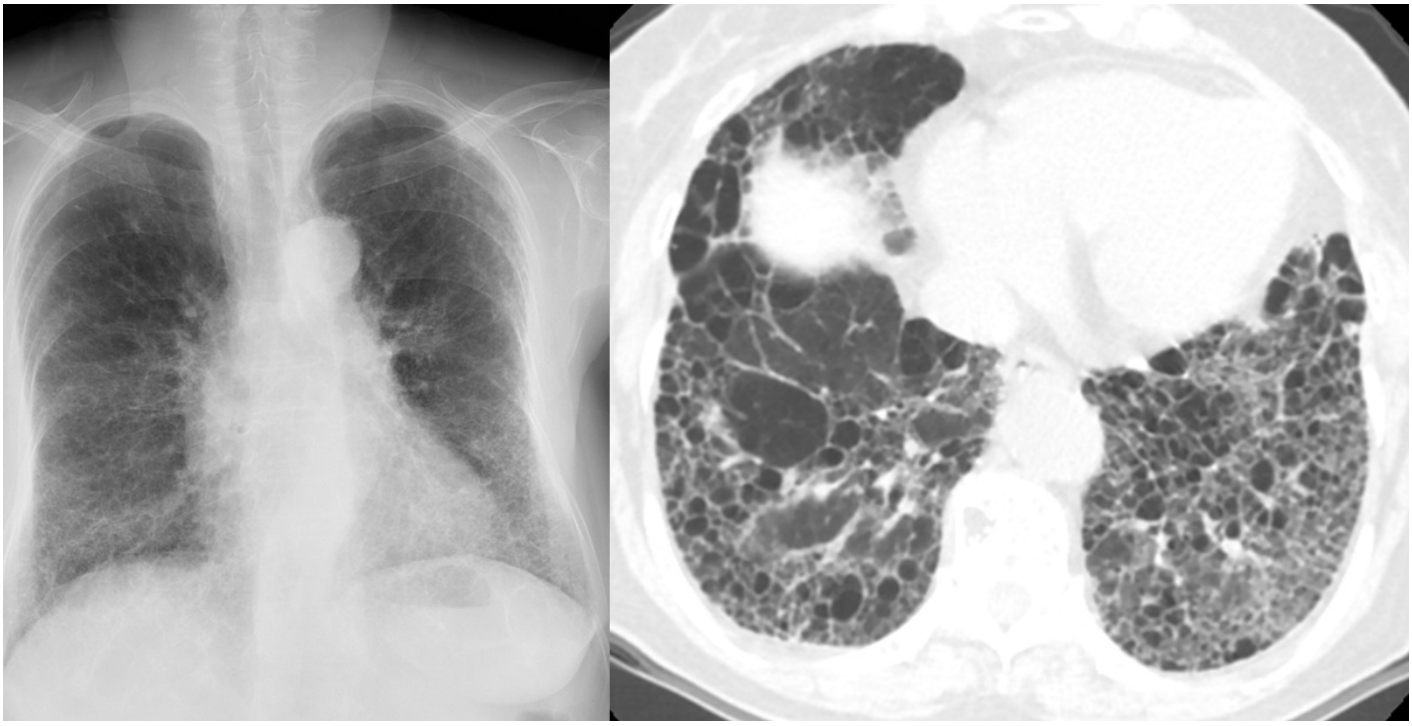
⑤ 우측 늑골횡경막각(costophrenic angle)의 blunting이 보이며 흉막삼출이 동반되어 있다.

> **정답 ②**
>
> 오른쪽 폐 일부에 폐혈관 음영이 없는 투명한 공간과 쪼그라든 폐의 경계선(흉막선)이 보여 오른쪽 기흉이다. 오른쪽 아래에는 수평한 공기-액체층이 있어 흉막삼출이 동반되어 있다(수기흉). 틀린 설명은 ②로, 왼쪽 폐는 정상이며 오른쪽 폐 가장자리가 오히려 더 검게(투명하게) 보인다.

2020년

2020년 시험 79번

10. 다음 chest radiograph과 CT에서 보이는 소견과 가장 가능성이 높은 감별진단의 조합은?



① Consolidation -------- Pneumonia

② Ground glass opacity - Pneumocystis jiroveci pneumonia

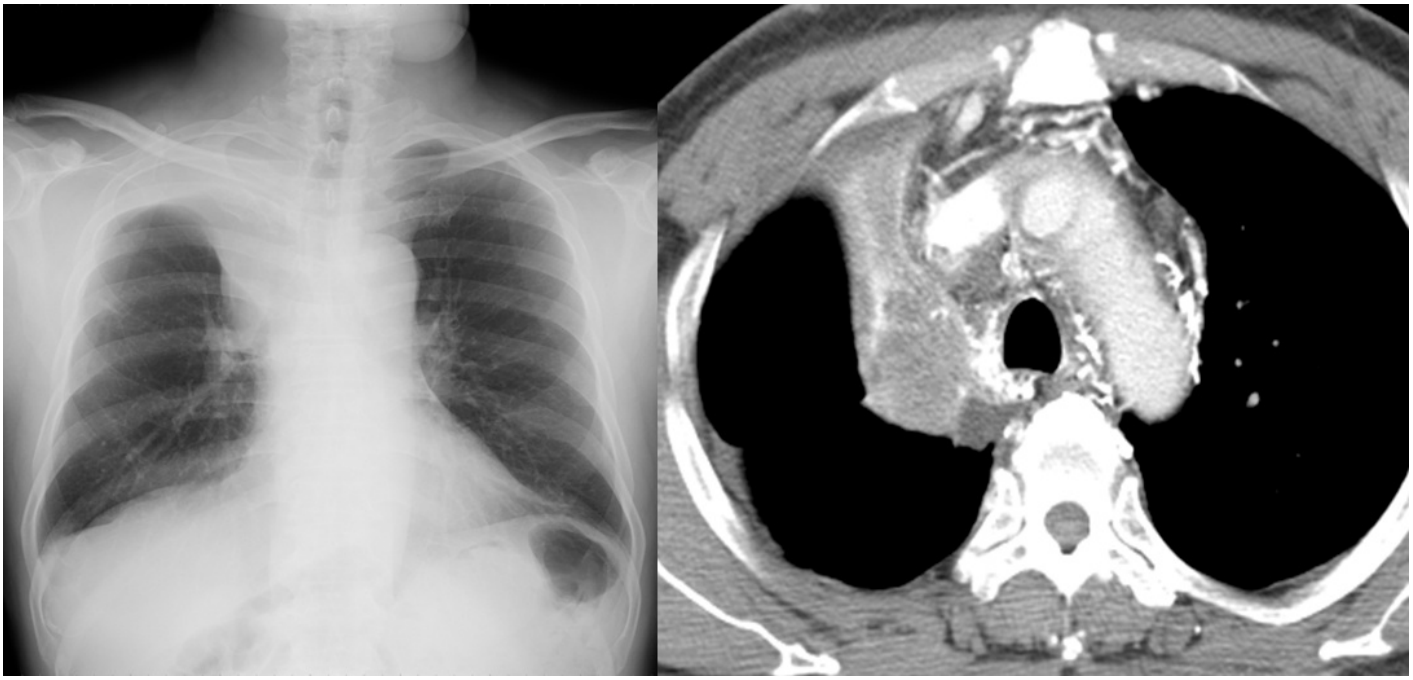
③ Miliary nodules - Miliary tuberculosis

④ Reticulonodular pattern - Idiopathic nonspecific interstitial pneumonia

⑤ Reticulonodular pattern - Idiopathic pulmonary fibrosis

> **정답 ⑤**
>
> 가슴 X선에서 양쪽 폐 아래쪽 · 가장자리에 우세한 그물결절(reticulonodular) 음영과 폐용적 감소가 있고, CT에서 흉막 아래에 벌집모양(honeycombing)이 뚜렷하다. 흉막하 · 하엽 우세 벌집모양은 UIP 패턴으로 특발성폐섬유증(IPF)을 시사한다(CT의 오른쪽 덩이는 IPF에 동반될 수 있는 폐암 등을 감별해야 함). NSIP는 간유리음영과 미세한 그물음영이 주이고 벌집모양이 드물며, 폐포자충폐렴은 간유리음영, 속립결핵은 작은 결절이 고르게 퍼진다.

11. 다음 흉부 x-선과 CT 영상에서 보이는 소견에 대한 설명으로 맞는 것은?



① 우상엽 (right upper lobe)의 무기폐 (atelectasis)로 경과 관찰한다.

② 우상엽 (right upper lobe)의 폐렴에 의한 경결 (consolidation)으로 항생제 치료한다.

③ 기관지 파급 결핵 소견으로 항결핵제 치료한다.

④ **기관지 폐암으로 진단을 위해 기관지내시경 (bronchoscopy)이 필요하다.**

⑤ 흉강내 농흉 소견으로 배액치료가 필요하다.

> **정답 ④**
>
> 가슴 X선에서 오른쪽 위 폐야가 하얗게 줄어들어 있고(우상엽 허탈), CT에서 우상엽 기관지 근처의 중심성 종괴가 기관지를 막아 그 뒤쪽 폐가 허탈되어 있다(Golden S 징후). 중심성 종괴에 의한 폐쇄성 무기폐는 기관지 폐암을 시사하므로 조직진단을 위해 기관지내시경이 필요하다. 단순 무기폐로 경과 관찰하거나 폐렴으로만 치료해서는 안 된다.